

表2 表1の耐性菌リスクを細分化

耐性菌のリスク因子
■医療・介護関連肺炎、医療ケア関連肺炎の耐性菌のリスク因子（SR4）
1. 経腸栄養
2. 入院後早期の挿管による人工呼吸器管理
3. 過去90日以内の抗菌薬使用歴
4. 低アルブミン血症
5. 過去90日以内の入院歴
6. 免疫抑制状態
7. 【緑膿菌について】慢性呼吸器疾患の既往も追加
■院内肺炎＋人工呼吸器関連肺炎における耐性菌のリスク因子（SR10）
1. ICUで発症
2. 敗血症/敗血症性ショック
3. 過去90日以内の抗菌薬使用歴
4. 活動性の低下、歩行不能
5. CKD（透析を含む）

[日本呼吸器学会成人肺炎診療ガイドライン2024作成委員会（編）：成人肺炎診療ガイドライン2024，メディカルレビュー社，2024より作成]

である。また迅速検査としてマイコプラズマ抗原検査や遺伝子検査，レジオネラ尿中抗原検査，肺炎球菌の尿中や喀痰中抗原検査などがある。

医療・介護関連肺炎や院内肺炎ではMRSAや緑膿菌などの薬剤耐性菌が原因菌となることが多く，原因菌検索や薬剤感受性試験は重要である（図1）。

治療と予後

エンピリック治療を表4に示す。重症例では広域抗菌スペクトルを有する薬剤が使用される。院内肺炎や医療・介護関連肺炎では誤嚥による肺炎が多く口腔内常在菌や嫌気性菌を考慮した抗菌薬の選択が重要である。

重症例や高齢者などでは予後不良となる場合がある。医療・介護関連肺炎や院内肺炎では，反復する誤嚥性肺炎や疾患の終末期に対して積極的な肺炎治療が生命予後やQOLを改善するとは限らず，患者個人の意志やQOLを考慮した治療や緩和ケアを選択肢として提示することがガイドラインで推奨されている。

表3 市中肺炎における細菌性肺炎とマイコプラズマ肺炎の鑑別

- 1) 年齢60歳未満
- 2) 基礎疾患がない，あるいは軽微
- 3) 頑固な咳がある
- 4) 胸部聴診上所見が乏しい
- 5) あるいは迅速診断法で原因菌が証明されない*
- 6) 末梢血白血球数が $10,000/\mu\text{L}$ 未満である

*マイコプラズマ抗原または遺伝子検査陽性を除く。

[日本呼吸器学会成人肺炎診療ガイドライン2024作成委員会（編）：成人肺炎診療ガイドライン2024，メディカルレビュー社，p32，2024より許諾を得て転載]

肺炎の予防

予後不良の肺炎が増加していることから肺炎の予防が重要である。肺炎球菌ワクチンおよびインフルエンザワクチンの併用接種が強く推奨されており，口腔ケアが人工呼吸器関連肺炎および医療・介護関連肺炎の予防として強く推奨されている¹⁾。肺炎球菌ワクチンには，23価莢膜多糖体型肺炎球菌ワクチン（PPSV23）15価と20価の蛋白結合型肺炎球菌ワクチン（PCV15とPCV20）があり，65歳以上の成人に対するPPSV23の定期接種が行われている。結合型肺炎球菌ワクチンを組み合わせることで，より効果的な予防が可能になるため，接種方法について学会からの提案が示されている²⁾。

文 献

- 1) 日本呼吸器学会成人肺炎診療ガイドライン2024作成委員会（編）：成人肺炎診療ガイドライン2024，メディカルレビュー社，2024
- 2) 日本呼吸器学会 感染症・結核学術部会ワクチンWG/日本感染症学会ワクチン委員会/日本ワクチン学会・合同委員会：65歳以上の成人に対する肺炎球菌ワクチン接種に関する考え方，第6版，2024. https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/o65haienV/o65haienV_240930.pdf（2024年12月26日閲覧）